

- 78★★★
☑☑☑ PS 0~2、71 歳以上ではプラチナ製剤併用の化学療法は推奨されない。
- 79★★★
☑☑☑ 小細胞癌の refractory relapse では抗 PD-L1 抗体の投与が推奨されている。
- 80★★★
☑☑☑ sensitive relapse に対するシスプラチン+エトポシド+イリノテカン
の併用療法では、顆粒球コロニー形成刺激因子 (G-CSF) 製剤の
予防投与で発熱性好中球減少症の頻度が 10% 以下に抑えられる。
- 81★★★
☑☑☑ 限局型小細胞肺癌に対する同時化学放射線療法が奏功した場合、
60 Gy/30 fr の予防的全脳照射が検討される。
- 82★★★
☑☑☑ 高頻度マイクロサテライト不安定性 (MSI-High) を有する非小細胞
肺癌では、ペムブロリズマブ が承認されている。
- 83★★★
☑☑☑ 肺神経内分泌腫瘍に対してはエベロリムスが承認されている。

腺様嚢胞癌 84 ~ 88

- 84★★★
☑☑☑ 喫煙はリスク因子ではない。
- 85★★★
☑☑☑ 男性に多い。
- 86★★★
☑☑☑ 腺様嚢胞癌は健診で発見されることが多い。
- 87★★★
☑☑☑ 病理像としては篩状構造が特徴的であり、その他に腺管状、充実性
胞巣もみられる。
- 88★★★
☑☑☑ 低悪性度腫瘍であり、遠隔転移をすることはない。

転移性肺腫瘍 89 ~ 92

- 89★★★
☑☑☑ 血管肉腫の肺転移では血胸を生じることがある。
- 90★★★
☑☑☑ 転移性肺腫瘍の外科治療では、全例でリンパ節郭清を行うことが推
奨されている。